

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ÍNDICE INTERNACIONAL DE FUNCIÓN ERÉCTIL (IIEF-15)

Eje VI: Conducta de Salud y Urología • Estándar Oro Mundial de Función Eréctil de Raymond Rosen

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF; versión completa 15 ítems e IIEF-5 abreviado).
Nombre Original	International Index of Erectile Function (IIEF; Rosen et al., 1997; Pfizer Inc. / UMDNJ).
Autores Originales	Raymond C. Rosen, Ph.D., A. Cappelleri, M. D. Smith, J. Lipsky y B. M. Peña.
Adaptaciones Hispánicas	Martín-Morales et al. (2001; estudio EDEM en España); Bobes et al. (2002).
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Urología. Disfunción eréctil, satisfacción coital y función orgásmica masculina.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme específico para varones sexualmente activos en las últimas 4 semanas.
Composición de Ítems	15 ítems evaluados en escala tipo Likert de 0 a 5 puntos agrupados en 5 dominios clínicos.
Población y Rango	Varones adultos (≥ 18 años); estándar regulatorio en ensayos clínicos de urología.
Tiempo de Administración	8 a 10 minutos de cumplimentación autónoma presencial o telemática.
Régimen de Licencia	Instrumento estandarizado de acceso abierto para práctica clínica y ensayos académicos.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CRITERIO REGULATORIO INTERNACIONAL

El IIEF fue concebido en la Escuela de Medicina Robert Wood Johnson como el instrumento primario de eficacia clínica para el desarrollo de los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (PDE-5):

- Validación Cruzada Internacional:** Validado simultáneamente en más de 10 países e idiomas, demostrando una altísima estabilidad transcultural en la evaluación de la salud sexual masculina.
- Aislamiento del Dominio Eréctil Puro:** Permite separar el fallo hemodinámico puramente eréctil (preguntas 1 a 5 y 15) de otras dificultades como la eyaculación precoz, el hipoandrogenismo o los problemas afectivos de pareja.
- Sensibilidad Cuantitativa al Tratamiento:** Detecta incrementos específicos de puntuación tras intervenciones farmacológicas, vasculares o psicoterapéuticas.

3. LOS 5 DOMINIOS CLÍNICOS DEL IIEF (15 ÍTEMES)

Dominio Clínico IIEF	Rango Pts	Reactivos y Procesos Fisiológicos Explorados
1. Función Eréctil (FE)	1 a 30 puntos	Ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 15: Frecuencia de erección, rigidez suficiente, penetración y mantenimiento.
2. Función Orgásmica	0 a 10 puntos	Ítems 9 y 10: Frecuencia de eyaculación y sensación de orgasmo con o sin estimulación.
3. Deseo Sexual	2 a 10 puntos	Ítems 11 y 12: Frecuencia e intensidad del apetito sexual en las últimas 4 semanas.
4. Satisfacción en el Coito	0 a 15 puntos	Ítems 6, 7 y 8: Número de intentos coitales logrados y disfrute específico de la penetración.
5. Satisfacción Global	2 a 10 puntos	Ítems 13 y 14: Satisfacción general con la vida sexual propia y la relación de pareja.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

El Estudio EDEM (Martín-Morales et al., 2001; $N > 2400$) y las validaciones de Bobes et al. (2002) confirman su precisión:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna (FE)	Alfa de Cronbach = 0.91 - 0.95	Extraordinaria homogeneidad métrica en el dominio central de función eréctil.
Confiabilidad en Dominios	Alfa = 0.84 - 0.90	Elevada coherencia interna en las 4 dimensiones complementarias.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.84 - 0.88$	Alta estabilidad temporal en intervalos de 4 semanas en pacientes no tratados.
Sensibilidad Diagnóstica	Sensibilidad = 94%	Excelente capacidad para discriminar varones con disfunción de controles sanos.
Sensibilidad al Cambio	Efecto $d = 1.30 - 1.85$	Gran potencia para registrar respuesta a inhibidores de PDE-5 (sildenafil).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DEL DOMINIO ERÉCTIL

- **Opciones de Respuesta:** La mayoría de los ítems se puntúan de 0 o 1 a 5 según la frecuencia o dificultad experimentada.
- **Cálculo del Dominio Función Eréctil (FE):** Sumatoria de los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 15:

$$\text{Puntuación Dominio FE} = \text{Ítems } (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 15) \quad (\text{Rango: } 1 \text{ a } 30 \text{ puntos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** Menores puntuaciones indican mayor gravedad de la disfunción eréctil. Puntuaciones de 26 a 30 representan normalidad funcional.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntos FE (1-5,15)	IIEF-5 Equiv.	Estado Clínico y Gravedad Eréctil (Rosen et al.)
Función Normal	26 a 30 puntos	22 a 25 pts	Erecciones normales, firmes y mantenidas sin dificultad clínica.
Disfunción Leve	22 a 25 puntos	17 a 21 pts	Punto de corte clínico fallos ocasionales de rigidez o mantenimiento.
Disfunción Leve-Mod.	17 a 21 puntos	12 a 16 pts	Erección suficiente en menos de la mitad de los intentos coitales.
Disfunción Moderada	11 a 16 puntos	8 a 11 pts	Dificultad casi constante para lograr la penetración vaginal.
Disfunción Severa	<= 10 puntos	<= 7 pts	Incapacidad eréctil completa ausencia total de erección funcional.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO CANÓNICO (DOMINIO FE < 26 PUNTOS):

Una puntuación en el **Dominio de Función Eréctil inferior a 26 puntos** (o **<= 21 puntos en la versión abreviada IIEF-5**) define la presencia de disfunción eréctil clínicamente significativa. En varones mayores de 45 años, la disfunción eréctil es con frecuencia un síntoma centinela de enfermedad endotelial o cardiopatía isquémica silente.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DISFUNCIÓN ERÉCTIL

PROTOCOLO UROLÓGICO Y SEXOLÓGICO CON EL IIEF:

- **Paso 1 (Administración en Consulta):** Asegurar que el paciente haya tenido al menos un intento sexual en el último mes; computar el Dominio FE (ítems 1-5, 15).
- **Paso 2 (Despistaje Médico Vascular y Hormonal):**
 - Si Dominio FE < 26, solicitar perfil lipídico, glucemia, HbA1c y testosterona total matutina.
 - Evaluar si el paciente toma betabloqueantes, diuréticos tiazídicos o psicofármacos.
- **Paso 3 (Tratamiento Escalonado):**
 - **Primera Línea:** Inhibidores de PDE-5 (**Tadalafilo** 5 mg diario o 20 mg a demanda; **Sildenafil** 50-100 mg a demanda) si no consume nitratos.
 - **Componente Psicológico:** Terapia sexual cognitivo-conductual (focalización sensorial) para neutralizar la ansiedad de ejecución anticipatoria.
- **Paso 4 (Verificación de Eficacia):** Un incremento de ≥ 4 puntos en el Dominio FE representa una mejoría clínicamente significativa.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TRATAMIENTO INTEGRADO DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Identificación: Varón de 56 años, directivo de banca con hipertensión tratada con enalapril, que consulta por pérdida de confianza y fallos repetidos para mantener la erección con su cónyuge desde hace 8 meses, evitando progresivamente cualquier aproximación íntima.

Evaluación con el Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF-15):

- **Dominio Función Eréctil (FE): 12 / 30 puntos (Disfunción Eréctil Moderada).**
- **Desglose de los otros 4 Dominios:**
 - Función Orgásmica: 6 / 10 puntos (eyaculación preservada pero insatisfactoria).
 - Deseo Sexual: 7 / 10 puntos (deseo e interés intactos).
 - Satisfacción en el Coito: 4 / 15 puntos (marcado sentimiento de fracaso).
 - Satisfacción Global: 3 / 10 puntos (alta frustración y evitación).

Estudio Orgánico: Analítica con glucemia y testosterona normales; ECG sin alteraciones isquémicas.

Intervención: Pauta de Tadalafilo 5 mg/día en toma continuada matutina asociada a psicoeducación sexológica para desarticular el rol de “espectador auto-observador” ansioso.

Reevaluación a las 6 Semanas: El Dominio FE aumentó espectacularmente de 12 a **27 puntos** (normalización de la rigidez), recuperándose la espontaneidad y la satisfacción coital plena (Satisfacción en el Coito = 13/15).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CONTRAINDICACIÓN DE NITRATOS:

Está terminantemente prohibido asociar inhibidores de PDE-5 con nitratos (cafinitrina, parches de nitroglicerina) por riesgo de colapso hipotensivo mortal.

ERECCIONES MATUTINAS:

La conservación de erecciones matutinas o nocturnas involuntarias orienta hacia una etiología predominantemente psicógena y reactiva por ansiedad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Rosen, R. C., Riley, A., Wagner, G., et al. (1997). The International Index of Erectile Function (IIEF): A multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. *Urology*, 49(6), 822-830.
2. Martín-Morales, A., et al. (2001). Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: Results of the EDEM study. *The Journal of Urology*, 166(2), 569-575.
3. Cappelleri, J. C., et al. (1999). Diagnostic evaluation of the erectile function domain of the International Index of Erectile Function. *Urology*, 54(2), 346-351.
4. Bobes, J., Bulbena, A., et al. (2002). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*. Ars Médica.